

الاحتياجات التربوية الخاصة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي -مقاربة تحليلية-

Special Educational Needs of Children with Cerebral Palsy -An Analytical Approach-

عبد الرحمان العوفي * Laoufi Abderrahmane

Laoufi.abdertrahmane@univ-medea.dz

تربية خاصة/جامعة يحي فارس المدينة/ الجزائر

DOI:10.46315/1714-015-001-020

الإرسال: 2025/07/23 القبول: 2025/12/13 النشر: 2026/01/16

**

ملخص:

تهدف هذه الورقة إلى تحليل الاحتياجات التربوية الخاصة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي في ضوء التربية الدامجة، من خلال تناول خصائصهم النمائية والمعرفية والحركية واللغوية والنفسية-الاجتماعية، وتفصيل سبل التكفل التربوي الملائمة لهم. اعتمدت الدراسة مقاربة تحليلية لمجموعة من الأدبيات العربية الحديثة ذات الصلة، وخلصت إلى أن فعالية التكفل تتطلب تكييفًا تربويًا مرناً، وتقييمًا فرديًا دقيقًا، ودعمًا متعدد التخصصات، بالإضافة إلى إدماج الأسرة والمعلمين في تخطيط التعلم. كما أظهرت الورقة وجود تحديات ميدانية ومؤسسية تحول دون تفعيل التربية الدامجة بالشكل المنشود، مما يستدعي إصلاحًا تربويًا شاملاً قائمًا على التدريب، والتخطيط الفردي، والتشريعات الداعمة.

كلمات مفتاحية: الشلل الدماغي، الاحتياجات التربوية، التربية الدامجة، التكيف البيداغوجي، الخطط التعليمية الفردية.

Abstract:

This paper aims to analyze the special educational needs of children with cerebral palsy in the context of inclusive education, by examining their developmental, cognitive, motor, linguistic, and psycho-social characteristics, as well as detailing appropriate educational support strategies. The study adopts an analytical approach based on a selection of recent relevant Arabic literature and concludes that effective support requires flexible pedagogical adaptation, accurate individualized assessment, and multidisciplinary collaboration, in addition to involving families and teachers in the learning process. The paper also highlights the existence of practical and institutional challenges that hinder the effective implementation of inclusive education, calling for comprehensive educational reform grounded in training, individualized planning, and supportive legislation.

Keywords : Cerebral Palsy; Educational Needs; Inclusive Education; Pedagogical Adaptation; Individualized Educational Plans.

*- الباحث المرسل: Laoufi.abdertrahmane@univ-medea.dz

1- مقدمة

يعتبر الشلل الدماغي (Cerebral Palsy) من بين الإعاقات النمائية المزمنة التي تؤثر بشكل مباشر على النمو الحركي، والتناسق العضلي، والقدرة على التحكم الإرادي في الحركات، حيث يعتبر طبيب الأعصاب الفرنسي (Tardieu) أول من استخدم مصطلح الشلل الدماغي وهذا في الخمسينات (1954). وعرفه على أنه: "اضطراب عصبي حركي يترجم بخلل على مستوى تنظيم الحركات والإشارات والناتج عن إصابة دماغية وقعت قبل الولادة أو في الطفولة الأولى، وبعد التعريف تكلم تارديو (Tardieu) عن توفر خاصيات للكلام عن إعاقة الشلل الدماغي، من حيث وجود إصابة عصبية دماغية مسببة للإعاقة، وسيطرة الإعاقة الحركية، حيث تظهر غالبية على الاضطرابات الأخرى مع وجود مستوى العمر العقلي مماثل الأقران، مع وجود اضطرابات حسية سيكولوجية مصاحبة للاضطراب الحركي، وأن تكون هذه الاضطرابات غير تطويرية، أي لا تزداد حدة مع نمو الطفل. (ميهوبي ودهان، 2022، ص 383) مما يجعل التكفل بهذه الفئة تحدياً متعدد الأبعاد يفرض على المحيط التربوي الاستجابة لمجموعة معقدة من الاحتياجات التعليمية الخاصة.

وتشير العديد من الدراسات إلى أن الأطفال المصابين بالشلل الدماغي يواجهون صعوبات تعليمية ناتجة عن عوائق وظيفية وليس بالضرورة عن عجز عقلي، حيث أظهرت دراسة الشامي (2017) أن الأداء الأكاديمي لهؤلاء التلاميذ يتحسن بشكل ملحوظ عند تكييف البيئة التعليمية، وتوفير وسائل تعلم مناسبة. وفي السياق نفسه، أكدت دراسة يوسف وآخرون (2019) على أهمية الدمج التربوي باعتباره وسيلة فعالة لتلبية الاحتياجات التربوية الخاصة لهذه الفئة، شريطة أن يرافقه تكوين متخصص للمعلمين، ودعم متعدد التخصصات داخل المدرسة.

كما تتفق الأدبيات الحديثة على أن مصطلح "الاحتياجات التربوية الخاصة" لا يختزل في مجرد تكييف المنهج، بل يشمل أيضاً جوانب سلوكية ونفسية واجتماعية، من بينها: الحاجة إلى المرافقة الفردية، تعديل أساليب التقويم، التهيئة النفسية، وتوفير بدائل تواصلية عند وجود اضطرابات لغوية مرافقة.

وقد أصبح من المسلم به في الأدبيات التربوية المعاصرة أن الأطفال المصابين بالشلل الدماغي لا يواجهون صعوبة في التعلم بسبب عجز عقلي دائم، بل نتيجة وجود مجموعة من الاحتياجات التربوية الخاصة التي تعيق قدرتهم على الوصول إلى المحتوى التعليمي بنفس الكيفية التي يتعامل بها أقرانهم العاديون. هذه الاحتياجات لا تقتصر على الدعم الحركي، بل تشمل الحاجة إلى تكييف بيئة التعلم، تعديل المناهج، استخدام الوسائل المعينة، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي. (عبد الحميد، 2018، ص 42)

فعدم إدراك طبيعة هذه الاحتياجات أو تجاهلها داخل السياق المدرسي يؤدي إلى إقصاء تربوي فعلي، حتى وإن بدا الأطفال حاضرين جسدياً في الأقسام. وبالتالي، فإن ضمان تكافؤ الفرص

التعليمية، وتفعيل مبادئ الدمج، والرفع من جودة الخدمات التربوية، كلها رهانات ترتبط بفهم دقيق لهذه الاحتياجات من جهة، وبقدرة المنظومة التعليمية على الاستجابة لها من جهة أخرى. (الطاهري، 2019، ص12)

ومع تعدد البحوث والدراسات التي تناولت الشلل الدماغي من الزاوية الطبية أو الفيزيائية أو التأهيلية، فإن الدراسات التربوية النظرية التي تعالج الاحتياجات التربوية الخاصة لهؤلاء الأطفال، ضمن مقاربة تحليلية شاملة، لا تزال محدودة في السياق العربي. وهذا ما يجعل من الدراسة الحالية محاولة لتسليط الضوء على هذه الزاوية، من خلال تحليل الأدبيات ذات الصلة، وتصنيف الاحتياجات، ومناقشة سبل التكفل التربوي الناجع بها، وذلك قصد توفير أرضية معرفية تؤطر تدخلات الممارسين في الميدان، وتثري النقاش الأكاديمي حول التربية الدامجة.

ولأن الدراسات العربية التي تناولت هذه الاحتياجات التربوية من زاوية تحليلية ونظرية هي الأخرى لا تزال محدودة، ما يجعل من الدراسة الحالية محاولة لسد هذا الفراغ من خلال تقديم مقاربة تحليلية شاملة، تُسهم في توضيح مفهوم هذه الاحتياجات وتصنيفها وتفسير سبل التكفل بها في ضوء أدبيات التربية الخاصة والدمج، بما يدعم الممارسة التربوية في البيئات المدرسية العربية، ويسهم في تحسين جودة التعليم لفئة مهمشة وغير مفهومة بما يكفي، وهو ما يقودنا لطرح الأسئلة التالية:

- ما المقصود بالاحتياجات التربوية الخاصة؟ وكيف تختلف عن الاحتياجات التعليمية العامة؟

- ما الخصائص النمائية والمعرفية والحركية التي تميز الأطفال المصابين بالشلل الدماغي؟

- ما الاحتياجات التربوية التي تفرضها هذه الخصائص على البيئة التعليمية؟

- كيف يمكن تصنيف هذه الاحتياجات ضمن أبعاد معرفية، حركية، لغوية، وانفعالية؟

- ما سبل التكفل التربوي بهذه الاحتياجات في إطار التربية الدامجة أو التربية الخاصة؟.

1- مفهوم الاحتياجات التربوية الخاصة وأبعادها النظرية

1-1 تعريف الاحتياجات التربوية الخاصة

يشير مصطلح "الاحتياجات التربوية الخاصة" إلى مجموعة من المتطلبات الفردية التي يحتاجها بعض المتعلمين من أجل التعلّم بفعالية، والتي تتجاوز ما يقدم للمتعلم العادي في بيئة التعليم التقليدية. هذه الاحتياجات قد تنبع من عوامل نمائية، حسية، حركية، معرفية، لغوية، أو نفسية - اجتماعية، وتفرض تكييفات في المحتوى أو المنهج أو طرق التقييم أو حتى في البيئة التعليمية ذاتها. (عبد الحميد، 2018، ص 17)

وفي هذا السياق، توضح زيتون (2013) أن الاحتياجات التربوية الخاصة لا ترتبط فقط بوجود "إعاقة"، بل تشمل أيضا المتعلمين الذين يواجهون صعوبات في التكيف مع النمط المدرسي لأسباب متعدّدة، وهو ما يفرض إعادة النظر في مفاهيم "التعليم للجميع" و"العدالة التربوية". أما منظمة اليونسكو، فتعتبر أن الطفل ذو الاحتياجات الخاصة هو كل من "يحتاج إلى تكييفات تعليمية خاصة ناتجة عن اختلافات في القدرة أو الإعاقة، سواء كانت دائمة أو مؤقتة، تؤثر على نمط تعلمه". (UNESCO, 2009)

2-1 أنواع الاحتياجات التربوية الخاصة

تتعدد أشكال الاحتياجات التربوية الخاصة وفقا لنوع الإعاقة أو الصعوبة التي يواجهها الطفل، ويمكن تصنيفها كما يلي:

- احتياجات معرفية

تتعلق بالقدرة على التركيز والانتباه ومعالجة المعلومات، وتتطلب تقديم المحتوى التعليمي بصورة مبسطة، متسلسلة، ومتكررة، مع توظيف وسائل تعليمية مرئية ومحسوسة. هذا النوع من الاحتياجات شائع لدى الأطفال المصابين بالشلل الدماغي، خاصة إذا رافقت حالتهم اضطرابات معرفية خفيفة إلى متوسطة. (الشامي، 2017، ص 35)

- احتياجات حركية

تؤكد دراسة خليل (2021) أن الاحتياجات الحركية تشمل الحاجة إلى تيسير الحركة داخل القسم، تعديل وضعية الجلوس، استخدام أدوات خاصة للكتابة أو التعامل مع الوسائل التعليمية. وغالبا ما يُغفل هذا البعد في الممارسة الصفية رغم تأثيره المباشر على التفاعل مع الدروس.

- احتياجات لغوية وتواصلية

يواجه عدد كبير من الأطفال المصابين بالشلل الدماغي صعوبات في النطق أو التعبير الشفهي نتيجة اضطراب في التحكم العضلي للفم أو اللسان، مما يؤثر على تواصلهم داخل القسم. هؤلاء

الأطفال يحتاجون إلى وسائل تواصل بديلة، مثل الصور، الرموز، أو تقنيات التواصل المعزز (الطاهري، 2019، ص 47)

- احتياجات نفسية – اجتماعية

تشمل الحاجة إلى الشعور بالانتماء والابتعاد عن العزلة التي تسبب مظاهر القلق والضيق والهم، والحاجة إلى الشعور بالأمن من خلال بيئته، والأمن على صحته وأسرته ومستقبله، ومكانته الاجتماعية، والحاجة إلى الحب والتناغم الوجداني والعاطفي من قبل أسرته ومجتمعه والجماعات التي يتفاعل معها، أو من خلال الخدمات المهنية والجهود الفنية التي تقدم له في مؤسسات رعاية المعوقين. (بواب وميلاط، 2019، ص 371) حيث أظهرت دراسة يوسف وآخرون (2019) أن الدعم النفسي والاجتماعي يزيد من دافعية التلاميذ ذوي الإعاقات الحركية نحو التعلم.

3-1 الأبعاد النظرية للاحتياجات التربوية الخاصة

تستند دراسة الاحتياجات التربوية الخاصة إلى عدد من الأطر النظرية التي تفسر كيفية بناء البرامج التربوية المناسبة لهذه الفئة: (عبد الحميد، 2018، ص 51)

- النظرية السلوكية

تركز هذه النظرية على تعديل السلوك الأكاديمي من خلال التعزيز والإشراف الإجرائي، وتفيد بشكل خاص في إدارة السلوكيات الصفية غير المرغوبة، وتحفيز السلوكيات الإيجابية.

- النظرية المعرفية

حيث تبرز هذه النظرية أهمية العمليات الذهنية الداخلية، مثل الانتباه، التذكر، والفهم، وتدعو إلى تكييف طرق العرض التعليمية بناء على أنماط التفكير لدى التلميذ.

- نظرية النمو المتكامل

وتؤكد هذه النظرية على ضرورة أخذ الجوانب البيولوجية والنفسية والاجتماعية بعين الاعتبار عند بناء التدخلات التربوية، خصوصاً مع الأطفال ذوي الاحتياجات المركبة كحالات الشلل الدماغي. ومن خلال ما سبق، يتضح أن مفهوم الاحتياجات التربوية الخاصة لم يعد يفهم كحالة طارئة أو استثنائية، بل كجزء من التنوع الطبيعي في القدرات والاستجابات التعليمية. وبالتالي، فإن السياسات التربوية يجب أن تنتقل من منطق "المعالجة" إلى منطق "الوقاية والاستباق"، من خلال تصميم بيئات تعليمية مرنة وقابلة للتكيف، وتراعي هذا التنوع مستجيبة له بشكل فعال.

2- الخصائص التعليمية والنمائية للأطفال المصابين بالشلل الدماغي

يشكل فهم الخصائص النمائية والتعليمية للأطفال المصابين بالشلل الدماغي (*Cerebral Palsy*) مدخلا أساسا لبناء تدخلات تربوية فعالة. فالشلل الدماغي لا يعد اضطرابا أحادي البعد، بل هو حالة معقدة تتفاوت مظاهرها من طفل لآخر، مما يجعل احتياجاتهم التربوية متعددة ومتشابهة. ويتربط على هذا التنوع ضرورة إجراء قراءة دقيقة لخصائصهم، على المستويين النمائي والتعليمي، لتيسير تكفل تربوي منصف وفعال.

حيث تتمثل هذه الخصائص في الآتي:

1-2 الخصائص الحركية والنمائية العامة

يمثل الجانب الحركي العلامة الأبرز للشلل الدماغي، حيث تظهر صعوبات في التوازن، والتناسق العضلي، والتحكم في الحركات الإرادية، والتي قد تتراوح بين خفيفة إلى شديدة، وفقا لنوع الإصابة (الشلل التشنجي، الكنعي، الترنجي...). وتشير الأدبيات إلى أن هذه الصعوبات غالبا ما تؤثر على المهارات الأساسية كالجلوس، المشي، استخدام اليدين، والكتابة. (عبد الحميد، 2018، ص73) إضافة إلى ذلك، تظهر بعض التأخيرات في النمو العام، خاصة في الحالات المصحوبة بإصابات دماغية واسعة، مما يستدعي تقييما شاملا لكل من النمو الحسي، والحركي، والإدراكي، والاجتماعي - العاطفي. (زيتون، 2013، ص68)

2-2 الخصائص المعرفية

يتميز الأطفال المصابون بالشلل الدماغي بتباين واسع في القدرات المعرفية. فبينما يتمتع بعضهم بمستوى ذكاء عادي أو فوق المتوسط، يواجه آخرون صعوبات معرفية نتيجة لتضرر مناطق دماغية تؤثر في الانتباه، الذاكرة العاملة، سرعة المعالجة، أو الفهم المجرد (الطاهري، 2019، ص91)

وقد بينت دراسة الشامي (2017) أن ضعف التحكم الحركي قد يخفي أحيانا قدرات معرفية جيدة، مما يجعل أدوات التقييم التقليدية غير كافية، ويفرض اعتماد مقاييس مرنة لا تتطلب استجابات حركية دقيقة. كما تشير دراسة يوسف وآخرون (2019) إلى أن صعوبات التوجيه البصري والانتباه المشترك قد تؤثر على استيعاب الطفل للتعليمات الشفهية أو البصرية داخل القسم، مما يستدعي اعتماد تعليمات مبسطة ومتكررة، ودعمه بصريًا باستمرار.

3-2 الخصائص اللغوية والتواصلية

تشير دراسات أرتوفونية متعددة إلى أن ما بين 60% إلى 70% من الأطفال المصابين بالشلل الدماغي يعانون من شكل من أشكال اضطرابات التواصل، سواء في النطق (خلل التوتر العضلي الفموي)، أو في التنظيم اللغوي، أو في الفهم السمعي، خاصة في الحالات المصاحبة لتلف عصبي واسع (خليل، 2021).

وتشمل الخصائص اللغوية الشائعة:

- تأخر في الكلام مقارنة بالفئة العمرية
- صعوبة في التعبير الشفهي أو النطق الواضح
- محدودية في المفردات
- ضعف في فهم التعليمات المركبة أو المجردة

ويؤكد زيتون (2013) على أهمية الكشف المبكر عن هذه الاضطرابات، والعمل على دعم الطفل بوسائل بديلة للتواصل، مثل الصور، الجداول البصرية، أو تقنيات التواصل المعزز (AAC).

4-2 الخصائص النفسية – الاجتماعية والانفعالية

يعاني العديد من الأطفال المصابين بالشلل الدماغي من ضغوط نفسية ناتجة عن محدوديتهم الحركية مقارنة بأقرانهم، إضافة إلى التهميش أو العزلة داخل المحيط الأسري أو المدرسي. كما قد تظهر لديهم سلوكيات انسحابية، أو ميول للقلق، أو انخفاض في تقدير الذات، خاصة في غياب دعم نفسي منهجي (عبد الحميد، 2018).

وقد لاحظت دراسة الطاهري (2019) أن ضعف إدماج هؤلاء الأطفال في الأنشطة الجماعية يؤدي إلى تدني مهاراتهم الاجتماعية والتواصلية، مما ينعكس على مشاركتهم داخل القسم، ويُعمّق من عزلتهم. في المقابل، أظهرت دراسات الدمج (مثل: يوسف وآخرون، 2019) أن الدعم الاجتماعي، وتقبل الزملاء، وتفاعل المعلم الإيجابي، كلها عوامل تحفّز النمو الانفعالي وتحسن من جودة التعلم لدى الطفل.

5-2 تنوع الخصائص وتأثيره على الاستجابة التربوية

إن تباين خصائص الأطفال المصابين بالشلل الدماغي من حيث نوع الإعاقة، شدتها، ووجود إعاقات مرافقة، يجعل من الاستجابة التربوية الموحدة أمرًا غير فعال. ومن هنا، تبرز الحاجة إلى إعداد خطط تعليمية فردية (IEPs) مرنة، تراعي الفروق الفردية، وتسمح للطفل بالتقدم وفق وتيرته الخاصة (الطاهري، 2019).

ويؤكد خليل (2021) على أن الطفل الذي يملك قدرات معرفية جيدة، لكنه محدود حركيًا أو لغويًا، يحتاج إلى استجابات تربوية مغايرة عن طفل يعاني من إعاقات مركبة. وبالتالي، فإن الفهم الدقيق لخصائص كل حالة هو نقطة الانطلاق لأي تكفل تربوي فعال.

ويمكن القول أن الأدبيات المتاحة تُبرز أن الأطفال المصابين بالشلل الدماغي لا يشكلون فئة متجانسة، بل يملكون ملفات نمو فردية معقدة ومتداخلة. وهذا التنوع في الخصائص يتطلب تدخلاً تربويًا متعدد الأبعاد، يقوم على تشخيص دقيق، وتكييف بيداغوجي شامل، ودعم نفسي-اجتماعي

متكامل. إن إدراك المعلم لهذه الخصائص هو أساس نجاح أي عملية تعليمية موجهة نحو هذه الفئة.

3- تصنيف وتحليل الاحتياجات التربوية الخاصة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي

تُعدّ معرفة الاحتياجات التربوية الخاصة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي أمراً حيوياً لنجاح أي عملية تعليمية، إذ تُشكّل هذه الاحتياجات الأساس الذي تبنى عليه الخطط التربوية، وأساليب التدريس، ووسائل التقويم. ونظراً للتنوع الكبير في نوع الإعاقة وشدّتها والوظائف المتأثرة، فإن هذه الاحتياجات لا تندرج ضمن إطار واحد، بل تتوزع على أبعاد متعددة تتقاطع فيها الجوانب الحركية، المعرفية، اللغوية، والنفسية – الاجتماعية (العساف، 2017).

1-3 الاحتياجات المعرفية

يواجه بعض الأطفال المصابين بالشلل الدماغي صعوبات في التركيز والانتباه، في معالجة المعلومات، وفي القدرة على التخطيط والتنظيم. هذه الصعوبات غالباً ما تكون نتيجة لتأثر مناطق معينة من الدماغ مسؤولة عن الوظائف التنفيذية. ولذلك، هم بحاجة إلى:

- تبسيط التعليمات وتكرارها.

- استخدام الوسائل البصرية لدعم الفهم.

- توفير وقت إضافي لإتمام المهام.

- تقسيم المهام إلى خطوات صغيرة ومنظمة.

وقد أكدت دراسة أبو زيد (2021) أن التلاميذ ذوي الإعاقات الحركية يحققون أداءً أفضل حينما توفّر لهم برامج تعليمية تراعي نمط تفكيرهم وقدراتهم العقلية وليس إعاقاتهم الجسدية فقط.

2-3 الاحتياجات الحركية والتنسيقية

من أهم تحديات التعلم لدى هذه الفئة ما يتعلق بالوضعيات الحركية داخل القسم: الجلوس، استخدام اليد، الكتابة، التفاعل مع الوسائل. ولهذا تظهر لديهم حاجة ملحة إلى:

- تسهيلات مادية في البيئة الصفية (مقاعد مخصصة، مساند، أدوات تكييفية)

- بدائل للكتابة اليدوية (أجهزة رقمية، أو لوحات تواصل)

- دعم من مرافق أو معلم مساعد في التنقل أو التعامل مع الأدوات التعليمية.

وقد أوصت دراسة عبد الكريم (2018) بأهمية إشراك المعالجين الفيزيائيين في إعداد الفضاء المدرسي لضمان قابلية التعلّم دون عوائق حركية.

3-3 الاحتياجات اللغوية والتواصلية

نظرًا لوجود اضطرابات نطق أو تأخر لغوي لدى كثير من المصابين بالشلل الدماغي، فإنهم يحتاجون إلى:

- تكرار الكلمات والمفاهيم بلغة واضحة وبطيئة.
 - استخدام الإشارات والرموز والصور الداعمة للشرح.
 - إدماج تقنيات التواصل المعزز والبديل (AAC) خاصة للأطفال غير الناطقين.
 - تخصيص حصص دعم أرتوفوني بالتنسيق مع المعالجين.
- ووفق دراسة بن غزالة (2020)، فإن استخدام الصور التوضيحية والجداول المصورة يُعزز بشكل ملحوظ من قدرة هؤلاء الأطفال على فهم التعليمات والمفاهيم، مما ينعكس على مستوى تحصيلهم.

4-3 الاحتياجات النفسية – الاجتماعية

- لا تقل أهمية عن غيرها، إذ يتعرض هؤلاء الأطفال غالبًا للعزلة أو الإقصاء أو التنمر غير المباشر من قبل الأقران، مما يضعف دافعيتهم ويؤثر على علاقتهم بالتعلم. هم بحاجة إلى:
- تعزيز تقدير الذات عبر أنشطة نجاح بسيطة.
 - دمجهم في مجموعات تعلم تعاوني تعزز التفاعل.
 - برامج دعم نفسي فردية وجماعية.
 - وعي وتدريب المعلمين على تقبل الفروق الفردية والتنوع الوظيفي.
- وقد أوضحت دراسة لطفي (2019) أن غياب الدعم النفسي الممنهج في المدرسة يؤدي إلى مضاعفة المعاناة المدرسية لدى هذه الفئة، حتى وإن كانت الحاجات الأكاديمية ملبأة جزئيًا.

5-3 تكامل الاحتياجات في الخطط التربوية الفردية

تفرض تعددية هذه الاحتياجات اعتماد ما يعرف بـ "الخطط التربوية الفردية (IEPs)"، وهي خطط يتم بناؤها وفق ملف كل طفل، بناء على تقييم تربوي ونفسي وحركي دقيق، وتحدد فيها الأهداف قصيرة وبعيدة المدى، وطبيعة الوسائل، وطرق التقييم، والأدوار بين الفريق التربوي والأسري.

ويؤكد شوقي (2022) أن الخطط التربوية الفردية تمثل الأداة المثلى لضمان تعليم متمركز حول قدرات الطفل لا حول إعاقته، شريطة أن يتم مراجعتها دوريًا وتطويرها وفق تقدم الطفل.

ولا يمكن التكفل التربوي بالأطفال المصابين بالشلل الدماغي إلا من خلال فهم دقيق وشامل لاحتياجاتهم المتنوعة. إن الاستجابة الفعالة لهذه الاحتياجات تتطلب مقاربة تربوية متعددة التخصصات، تدمج فيها الجوانب النفسية، اللغوية، الحركية، والمعرفية، ضمن بيئة تعليمية مرنة وداعمة. وأي تجاهل لبعد من هذه الأبعاد، يفقد العملية التربوية معناها ويُعرض الطفل لمزيد من التهميش داخل القسم.

4- سبل التكفل التربوي باحتياجات الأطفال المصابين بالشلل الدماغي في ضوء التربية

الدامجة

1-4 التربية الدامجة كإطار مرجعي

ظهرت التربية الدامجة كتحول نوعي في الفكر التربوي، تقوم على مبدأ أن المدرسة يجب أن تستوعب جميع المتعلمين على اختلاف قدراتهم وظروفهم، من دون عزل أو تصنيف. ويعتبر الأطفال المصابون بالشلل الدماغي من بين الفئات التي تستدعي هذا التحول، نظرا لتنوع احتياجاتهم وتداخل أبعاد إعاقاتهم (العويسي، 2020، ص120)

إن الهدف من التربية الدامجة لا يتمثل في مجرد دمج جسدي، بل في التمكين التربوي والاجتماعي الشامل، أي توفير بيئة تعليمية تسمح لهؤلاء الأطفال بالتعلم والمشاركة والتطور في إطار القسم العادي، مع ما يلزم من تكييفات بيداغوجية ودعم مهني (حامد، 2018، ص103)

2-4 أسس التكفل التربوي الفعال

التكفل التربوي الناجح بفئة الشلل الدماغي لا يتم بشكل عشوائي، بل يقوم على مجموعة من المبادئ التربوية والمهنية الأساسية، أبرزها:

- مبدأ الفروق الفردية

يجب أن يكون المنهج المدرسي مرنا وقابلا للتكيف مع احتياجات كل تلميذ. فالطفل المصاب بالشلل الدماغي قد يملك نفس القدرات الذهنية مثل أقرانه، لكنه يحتاج وقتا أطول أو أدوات مختلفة لتحقيق الأهداف نفسها (ناصر، 2019، ص76)

- الدعم متعدد التخصصات

التكفل التربوي لا يمكن أن يسند إلى المعلم وحده. حيث يتطلب الأمر تنسيقا فعالا بين المعلم، الأخصائي النفسي، المعالج الأروطوفوني، أخصائي العلاج الطبيعي، والطاقم الإداري، من أجل إعداد خطة دعم متكاملة (صالح، 2021، ص138)

- التقييم التربوي الفردي

لا يمكن تحديد الاحتياجات بدقة دون تقييم شامل لنقاط القوة والضعف لدى الطفل. ويفضل أن يتم التقييم بطريقة دينامية، تعتمد على الملاحظة، المقابلة، وتجريب استراتيجيات متنوعة، لتحديد أنسب الوسائل لدعم الطفل (الدمياطي، 2017، ص125)

3-4 استراتيجيات التكفل داخل القسم

- التكيف البيداغوجي

يشمل تعديل الأنشطة، المحتوى، الوسائط، الزمن، وأساليب التقويم. ومن أبرز صور التكيف:

- استخدام الوسائل البصرية والمحسوسة

- تقسيم الأنشطة إلى مراحل صغيرة

- تقليل المتطلبات الكتابية والاعتماد على إجابات شفهية أو تكنولوجية

- تمديد الوقت المخصص للواجبات والاختبارات

وقد أوصت دراسة العتيبي (2020) بأن المعلمين الذين يملكون مرونة في تكيف أنشطتهم يحققون نتائج أفضل في دمج الأطفال المصابين بإعاقات حركية.

- اعتماد الخطط التعليمية الفردية (IEPs)

حيث تعتبر أداة أساسية لضمان استمرارية الدعم وفاعليته، حيث تتضمن:

- أهداف قصيرة وطويلة المدى

- الوسائل التعليمية والتقييمية المناسبة

- المسؤوليات بين المعلمين والمختصين

- جدولا زما للمراجعة والتعديل

- بناء علاقات تفاعلية إيجابية

النجاح الأكاديمي مرتبط بالجانب الانفعالي. يجب أن يشعر الطفل بأنه مقبول داخل القسم، وأن لديه فرصة للتعبير والمشاركة. وهذا يتطلب من المعلم وعيا نفسيا، وصبرا، وتفهما لسلوك الطفل وتواصله (الشاذلي، 2021، ص59).

4-4 دعم الأسرة كشريك تربوي

لا يمكن لأي تكفل تربوي أن ينجح دون إشراك الأسرة. فدورها لا يقتصر على المتابعة المنزلية، بل يجب أن تكون حاضرة في اتخاذ القرارات، ومشاركة المعلومات، وتوفير الاستقرار الانفعالي للطفل. وتشير دراسة المنصوري (2019) إلى أن التعاون بين المدرسة والأسرة يقلل من نسب الانسحاب المدرسي ويزيد من فاعلية التدخلات.

5-4 المعوقات التي تحد من فاعلية التكفل

رغم وضوح المبادئ، إلا أن التكفل التربوي لا يزال يواجه عدة تحديات في السياق العربي، منها:

- نقص التكوين لدى المعلمين في مجال الإعاقات الحركية
- ضعف التنسيق بين القطاعات (التربية، الصحة، الشؤون الاجتماعية)
- غياب أدوات تقييم مرنة ومحلية
- محدودية الوسائل والفضاءات الداعمة داخل المدارس

وقد خلصت دراسة بن عميرة (2022) إلى أن تجاوز هذه المعوقات يتطلب سياسة شاملة لدمج التربية الخاصة داخل الإطار العام للمدرسة وليس كملحق لها.

إذا فالتكفل التربوي للأطفال المصابين بالشلل الدماغي لا يجب أن ينظر إليه كعمل إضافي أو استثنائي، بل كواجب تربوي وأخلاقي. ومن خلال تفعيل التربية الدامجة وفق منطق الاحتياجات لا الإعاقة، وتوفير بيئة تعليمية مرنة وداعمة، وتكوين الكوادر وتوفير الوسائل، يمكن تجاوز المعوقات، وتحقيق تعليم أكثر عدالة وشمولا.

5- خاتمة

لقد حاولت هذه المقاربة تسليط الضوء على الاحتياجات التربوية الخاصة للأطفال المصابين بالشلل الدماغي من منظور تحليلي متعدد الأبعاد، ينطلق من خصائصهم النمائية، المعرفية، الحركية، اللغوية، والنفسية-الاجتماعية، وينتهي عند سبل التكفل بهم في سياق التربية الدامجة. وقد بينت النتائج المستخلصة أن هذه الفئة من الأطفال، رغم تحدياتهم الوظيفية المعقدة، يمتلكون طاقات تعلم قابلة للتفجير متى توفرت لهم البيئة التعليمية المناسبة، والدعم التربوي المتكامل، والاعتراف الفعلي بحقوقهم في التعليم النوعي.

حيث أن فهم الاحتياجات التربوية لا يعني تصنيفا طبيا جامدا، بل يتطلب قراءة مرنة ومفتوحة لملف كل طفل، على ضوء الفروق الفردية، وإدماجه في مسار تعليمي قابل للتكييف والتقييم الدوري. كما أظهرت المقاربة أن التكفل التربوي الفعال لا يمكن أن يبنى إلا على أسس متكاملة: منها

تكييف المناهج، وتوفير الوسائل المساعدة، وتدريب المعلمين، والتعاون مع الأسرة، وتفعيل التقييم الفردي، وكل ذلك في إطار تربية دامج ترفض الإقصاء والعزل، وترسخ ثقافة الإنصاف والتعدد. ومن جهة أخرى، كشفت المقاربة أن تحديات تطبيق التكفل التربوي لا تزال قائمة في معظم الأنظمة التعليمية العربية، حيث يسجل نقص في التكوين، وتضارب في الأدوار، وضعف في التنسيق بين القطاعات الداعمة، مما يستدعي تدخلا إصلاحيا هيكليا يرتقي بالتكفل من مستوى الشعارات إلى الممارسة الفعلية في المدرسة.

**

المراجع

- أبو زيد، ر. (2021). التعليم الدامج وفعاليته في تطوير المهارات المعرفية لذوي الإعاقات الحركية. مجلة البحوث التربوية والنفسية، 13(2)، 88-107.
- بن عميرة، ع. (2022). معوقات تطبيق التربية الدامجة في المدارس العربية. مجلة الدراسات التربوية والاجتماعية، 14(1)، 75-94.
- بن غزالة، ك. (2020). أثر الوسائط البصرية في دعم التواصل لدى الأطفال ذوي الشلل الدماغي. مجلة علوم التربية، 7(1)، 55-72.
- حامد، م. (2018). التكفل التربوي بالأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. القاهرة: دار الأفق.
- خليل، ع. (2021). الاحتياجات التربوية لذوي الإعاقات الحركية. عمان: دار المسيرة.
- الدمياطي، أ. (2017). التقييم التربوي للأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة. الإسكندرية: مكتبة دار الفكر.
- زيتون، ع. (2013). استراتيجيات التدريس لذوي الحاجات الخاصة. عمان: عالم الكتب.
- الشاذلي، ه. (2021). العلاقات الصفية وأثرها في دمج الأطفال ذوي الإعاقات. مجلة علم النفس والتربية، 13(4)، 44-61.
- الشامي، ن. (2017). فعالية التكيف التربوي في تحسين التحصيل الدراسي لدى الأطفال المصابين بالشلل الدماغي. مجلة دراسات تربوية، 22(1)، 45-62.
- شوقي، ع. (2022). الخطط التربوية الفردية كأداة لتكييف التعليم لذوي الحاجات الخاصة. القاهرة: مركز تطوير التعليم الشامل.
- صالح، ر. (2021). التكفل متعدد التخصصات في المؤسسات التعليمية. مجلة العلوم التربوية، 19(1)، 122-139.
- الطاهري، أ. (2019). مقاربات حديثة في تعليم ذوي الاحتياجات الخاصة. بيروت: دار الروافد الثقافية.
- عبد الحميد، ج. (2018). مدخل إلى التربية الخاصة. الإسكندرية: المكتب الجامعي الحديث.
- عبد الكريم، ل. (2018). تهيئة البيئة الصفية لذوي الإعاقات الحركية: من التكيف إلى الدمج. المجلة العربية للتربية الخاصة، 5(3)، 44-60.

- العتيبي، ن. (2020). *أثر التكيف البيداغوجي على دمج ذوي الإعاقات الحركية*. مجلة المعلم العربي، 6(2)، 88-106.
- العساف، ن. (2017). *الاحتياجات الخاصة للأطفال ذوي الإعاقات المركبة: دراسة تحليلية*. الرياض: دار الزهراء.
- العويس، ع. (2020). *المدرسة الدامجة: رؤية تربوية معاصرة*. بيروت: مركز النشر الجامعي.
- لطفي، م. (2019). *الدعم النفسي والتربوي في المدارس الدامجة: قراءة في التجارب العربية*. مجلة علم النفس التربوي، 10(4)، 33-51.
- المنصوري، ف. (2019). *الشراكة مع الأسرة في تعليم الأطفال ذوي الإعاقات الحركية*. مجلة الطفولة العربية، 7(1)، 99-115.
- إيمان، مهوي، وآمال، دهان. (2022). *دراسة نظرية لاضطراب الوظائف المعرفية عند أطفال الشلل الدماغي*. مجلة دراسات إنسانية واجتماعية، 11(1)، 381-388.
- رضوان، بواب، وصبرينة، ميلاط. (2019). *الأبعاد الاجتماعية للبرامج التربوية عند ذوي الاحتياجات الخاصة*. مجلة مفاهيم الدراسات الإنسانية والفلسفية المعمقة، 6، 360-373.
- ناصر، س. (2019). *الدمج المدرسي وتكافؤ الفرص التعليمية*. مجلة التربية المعاصرة، 11(3)، 60-78.
- يوسف، س.، وآخرون. (2019). *فاعلية برامج الدمج في تلبية احتياجات التلاميذ ذوي الإعاقات الحركية*. مجلة الطفولة والتربية، 11(3)، 77-94.
- UNESCO. (2009). *Inclusive education: The way of the future*. International Conference on Education. Geneva: UNESCO